TUR Blaas

U wordt binnenkort opgenomen op de hospitalisatieafdeling Urologie voor een transurethrale resectie (TUR) van één of enkele letsels ter hoogte van de blaaswand.

Deze brochure wil u informeren over de geplande ingreep en wegwijs maken in het verloop van uw hospitalisatie. Mogelijk zijn niet alle thema's in deze brochure voor u van toepassing (fluorescentie en chemotherapie). Uw arts zal u vertellen of u deze voorbereiding of behandeling moet ondergaan.

Hebt u nog bijkomende vragen, dan kan u hiervoor uiteraard terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Wij wensen u alvast een spoedig herstel.

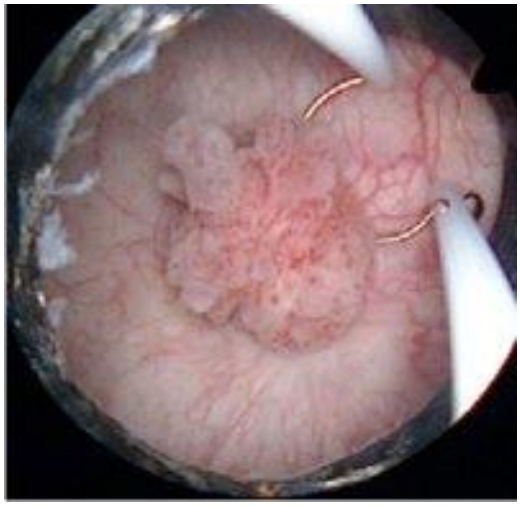
1. TUR Blaas

De ingreep die u zal ondergaan is een transurethrale resectie (TUR) van één of enkele letsels ter hoogte van de blaaswand. Deze ingreep wordt door de zorgverleners afgekort een TUR blaas genoemd.

Een TUR blaas gebeurt onder algemene verdoving (algemene narcose) of locoregionale verdoving (ruggenprik).

Tijdens de operatie brengt de Uroloog via uw plasbuis een instrument tot in de blaas. Langs deze weg kan de uroloog de blaaswand bekijken en letsels verwijderen. Het doel van de ingreep is tweevoudig. Uw arts zal de zichtbare letsels verwijderen én het verwijderde weefsel laten onderzoeken in een labo (anatomo-pathologisch onderzoek).

Onderzoek van het weefsel is belangrijk om te weten of de letsels goed- of kwaadaardig zijn. Zijn de letsels kwaadaardig dan kan het labo ook de graad van kwaadaardigheid bepalen en aangeven hoe diep de tumor ingegroeid is in de blaaswand. Deze gegevens zijn belangrijk voor het bepalen van een eventuele nabehandeling en om te voorspellen of de tumor snel kan terugkeren of ontaarden in een meer kwaadaardige vorm.



Afbeelding toont een blaastumor die wordt verwijderd aan de hand van een elektrische lus

2. Complicaties

Elke ingreep houdt bepaalde risico's in.

Vaak voorkomende complicaties (meer dan 1 op 10)

- Irritatieve plasklachten in de eerste 4-6 weken (branderig gevoel, vaker moeten plassen, ongewild urineverlies)

- Bloedverlies in de urine (kan tot 6 weken na de ingreep)
- Blaaskrampen

Soms voorkomende complicaties (1 op 100 tot 1 op 10)
- Urineweginfectie

Zelden voorkomende complicaties (minder dan 1 op 100)
- Nabloeding die extra zorg vraagt: heropname voor het verwijderen van grote klonters
- Blaasperforatie
- Blaashalsvernauwing of plasbuisvernauwing (urethrastrictuur)
- Langdurige incontinentie

3. Voorbereiding

Preoperatieve consultatie (POC)

Sommige patiënten worden best voorgaand aan de ingreep gezien door de anesthesist (indien je > 70j bent, belangrijke medische voorgeschiedenis hebt, BMI > 35 hebt, of indien je 5 of meer geneesmiddelen neemt). Zij bekijken samen met u welke preoperatieve onderzoeken noodzakelijk zijn: bvb ECG of bloedafname. Of u bij de anesthesist dient langs te gaan, wordt besproken op de consultatie met uw behandelend Uroloog.

Urinestaal

Minstens 2-3 weken voor de ingreep dient een urinestaal via uw huisarts/ziekenhuis te worden binnengebracht om infectie na te gaan. In geval van infectie zullen wij u contacteren en antibiotica opstarten.

Medicatie

Bloedverdunners dienen meestal tijdelijk gestaakt te worden. Bespreek dit met uw behandelend Uroloog.

Antibiotica wordt voorafgaand aan de ingreep opgestart op advies van uw behandelend Uroloog in functie van een afwijkend urinestaal. Dit wordt telefonisch met u besproken, zorg dat wij steeds een geldig telefoonnummer van u in ons dossier hebben staan door dit via ons secretariaat door te geven.

Vergeet zeker niet uw thuismedicatie mee te brengen bij de opname. Bij voorkeur in de originele verpakking.

Uur van ingreep

Twee werkdagen voor de geplande operatiedatum wordt u telefonisch gecontacteerd om door te geven om welk uur u verwacht wordt in het ziekenhuis. Dit wordt afgestemd op het richt uur van de operatie maar is geen bevestiging van een bepaald uur, pin u dus niet per se vast op dit moment.

4. Opname op de hospitalisatieafdeling

Voor deze ingreep wordt u opgenomen op de hospitalisatieafdeling Urologie omdat u één nacht in het ziekenhuis moet blijven. U brengt dus nachtkledij, toilet- en wasgerief mee. Een paar pantoffels en eventueel een kamerjas zijn handig. Als u anti-emboliekousen (= TED-kousen) hebt van een eerdere operatie, breng die dan ook mee.

De verpleegkundige of secretaresse van de hospitalisatieafdeling zal u verwelkomen en u naar uw kamer begeleiden. De verpleegkundige stelt u nog enkele vragen om de zorg op u af te stemmen. Het uur waarop de ingreep vermoedelijk zal doorgaan, wordt u meegedeeld.

Omwille van de verdoving die u zal krijgen, mag u vanaf middernacht voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.

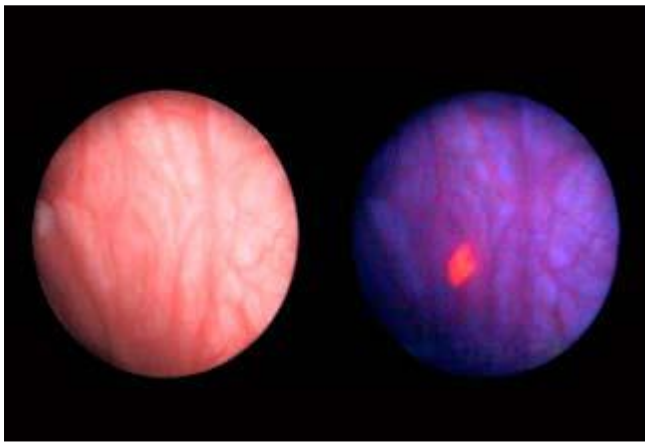
Als voorbereiding op de ingreep vragen wij u de intieme hygiëne te voorzien.

5. Fluorescentie

In bepaalde gevallen zal de arts beslissen om gebruik te maken van fluorescentie tijdens de ingreep. Dit wil zeggen dat de arts de blaaswand zal beschijnen met een blauw licht. Door het blauw licht gaan letsels die onzichtbaar zijn voor het blote oog oplichten (roze vlekken). Deze techniek is enkel nuttig bij vlakke letsels die niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Deze worden in de vaktaal 'carcinoma in situ' genoemd.

Als uw arts beslist dat hij fluorescentie zal gebruiken tijdens de ingreep, dan zal de verpleegkundige u daar één uur voor de ingreep op voorbereiden. Dit wil zeggen dat ze een sonde (hol, soepel buisje) doorheen de plasbuis in de blaas zal inbrengen. Nadat de sonde is geplaatst en de blaas is geledigd, zal ze doorheen de sonde een product (Hexvix®) toedienen. Nadat het product is toegediend, wordt de sonde verwijderd.

Het product wordt op een verschillende manier opgenomen door een gewone blaaswandcel dan door een tumorcel. Door het verschil in opname zal bij het beschijnen van de blaaswand met blauw licht een verschil in verkleuring optreden.



Afbeelding links toont blaaswand zonder fluorescentie.

Afbeelding rechts toont blaaswand met fluorescentie (blauw = normale blaaswand; roze = verdacht letsel)

Het product moet één uur in de blaas blijven. Als u het gevoel krijgt dat u moet plassen, probeer dit dan uit te stellen. Weet dat er op dat ogenblik slechts een 50-tal ml in de blaas zit. Een normale plas is ongeveer 350 ml, dus uw blaas is zeker nog niet vol.

6. Moment van de ingreep

Op het ogenblik dat uw arts u naar de operatiezaal vraagt, zal de verpleegkundige u een operatiehemdje geven om aan te trekken. U trekt dan alle andere kledij uit, net zoals juwelen, kunstgebit, hoorapparaat of bril. De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de bedhold (wachtzaal voor patiënten die geopereerd zullen worden).

Voordat u in slaap wordt gebracht, zal de Anesthesist u nog enkele vragen stellen. Het is mogelijk dat u uw Uroloog niet meer zal zien vlak voor u in slaap gaat, omdat hij pas binnenkomt als u al slaapt.

De ingreep duurt ongeveer 20 tot 60 minuten, maar is afhankelijk van het aantal letsels dat uw arts zal verwijderen.

7. Na de ingreep

Opname post-anesthesie zorgafdeling (PAZA)

Na de ingreep gaat u naar de PAZA of ontwaakzaal. Hier wordt u tijdens het ontwaken uit de verdoving strikt opgevolgd door de verpleegkundigen en de Anesthesist. U zal verbonden zijn met een monitor waarop uw bloeddruk, pols en ademhaling gevolgd worden. De verpleegkundigen geven u ook de voorgeschreven pijnstilling.

Na de ingreep hebt u ook een blaassonde doorheen uw plasbuis tot in de blaas. Dit is een soepel hol buisje, waarlangs de urine afloopt in een urinezak. Het hebben van een sonde is niet pijnlijk maar kan als onaangenaam ervaren worden. De sonde is eveneens verbonden met een grote spoelzak, waardoor het mogelijk is uw blaas continu te spoelen. De arts kiest voor deze continue spoeling omdat hij verwacht dat de prostaat mogelijk wat zal nabloeden. De verpleegkundige zal uw urine nauwkeurig opvolgen en de snelheid van deze spoeling aanpassen naargelang de kleur van de urine.

Het is mogelijk dat de sonde toch verstopt ondanks de continue spoeling. Het is daarom belangrijk om de verpleegkundige te waarschuwen wanneer u een druk in de onderbuik of een toenemend plasgevoel ervaart. In bepaalde situaties moet het systeem ontkoppeld worden om bloed en klonters te verwijderen door middel van manuele spoeling.

Wanneer de Anesthesist beslist dat het veilig is om u terug naar de hospitalisatieafdeling te brengen, zullen de verpleegkundigen u komen halen en terugbrengen. Het is best mogelijk dat u zich achteraf niet alles meer herinnert van het verblijf op de PAZA.

Terug op de kamer

Wanneer u terug op uw kamer bent, zal de verpleegkundige u helpen uw nachtkledij aan te trekken. U mag nog niet uit bed en de eerste uren mag u ook nog niets eten of drinken. De verpleegkundige zal u laten weten wanneer u water mag beginnen drinken. ’s Avonds kunt u een licht avondmaal krijgen.

De continue blaasspoeling wordt verdergezet op de hospitalisatieafdeling tot de urine helder is. De verpleegkundige volgt de spoelvloeistof nauwkeurig op. Ook hier is het belangrijk dat u de verpleegkundige waarschuwt wanneer u een drukkend gevoel in de onderbuik of een toenemende plasdrank ervaart. Van zodra de urine helder is, wordt de spoeling gestopt. De ochtend na de ingreep zal de arts beslissen of de sonde verwijderd mag worden. Het verwijderen van de sonde kan onaangenaam aanvoelen maar is doorgaans niet pijnlijk.

Na het verwijderen van de sonde zal de verpleegkundige uw plas opvolgen. Het is best mogelijk dat het plassen na de ingreep branderig aanvoelt. Dit is normaal en kan tot 24u na het verwijderen van de sonde voorkomen. Na elke plas zal de verpleegkundige met een speciaal echotoestel (“bladderscan”) controleren of u voldoende leegplast.

Chemotherapie

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een chemotherapie spoeling van de blaas enkele uren na de ingreep. Chemotherapie heeft een antitumorale werking bij oppervlakkige kankergezwellen in de blaas. Deze chemotherapie wordt rechtstreeks in de blaas toegediend om tumorcellen op de blaaswand te vernietigen.

Uw Uroloog kan beslissen om u enkele uren na de ingreep chemotherapie toe te dienen langs de blaassonde. De chemotherapie heeft één uur de tijd nodig om in de blaas in te werken. Het is mogelijk dat u al sneller het gevoel krijgt dat u moet gaan plassen. Deze plasdrang krijgt u omdat uw blaas geprikkeld wordt door het product. Probeer toch het product één uur op te houden.

Als het uur voorbij is, zal de verpleegkundige het product weer laten aflopen in de urineopvangzak die verbonden is met de blaassonde. Het is belangrijk dat alle chemotherapie goed afloopt. Nadien zal de verpleegkundige de continue spoeling weer laten lopen zodat eventuele resten van het product verwijderd worden uit de blaas.

Het toedienen van de chemotherapie is niet pijnlijk, maar kan u wel voelen. Tijdens de ingreep heeft de arts kleine wonden gemaakt in de blaaswand, waardoor het risico bestaat dat u dit product opneemt in

uw lichaam. De verpleegkundige zal u daarom observeren tijdens en na de toediening van de chemotherapie.

De chemotherapie is niet onschadelijk. De verpleegkundige zal daarom beschermingsmaatregelen treffen bij het toedienen van het product.

Het is niet vreemd dat u na de behandeling met het chemotherapeuticum plasklachten hebt zoals dringend plassen, frequent plassen, branderigheid bij het plassen en bloed in de urine. Deze klachten zijn normaal, maar mogen niet langer dan twee dagen duren.

Deze normale bijwerkingen verdwijnen meestal spontaan. Duren de klachten langer dan twee dagen, neem dan contact op met de dienst Urologie en vertel dat u een instillatie kreeg met een chemotherapeuticum.

Een andere, weinig voorkomende nevenwerking is een allergische reactie aan handen en genitaliën. Deze reactie kan 1 tot 2 dagen duren.

8. Ontslag

De arts beslist wanneer u naar huis kan gaan. Voordat u naar huis gaat, krijgt u van de secretaresse of verpleegkundige een controleafspraak om terug te keren naar uw Uroloog. Tijdens deze afspraak zal de Uroloog u het resultaat van het weefselonderzoek toelichten.

9. Nazorg en verwachtingen thuis

Drink voldoende water: liefst 1.5 liter water mooi gespreid over de dag.

Vermijd persen bij stoelgang maken, zo nodig dient een laxativum gestart te worden. Eveneens helpen vezelrijke voeding en groene kiwi's (tot 2 per dag) een vlotte stoelgang te bekomen.

Relatieve rust wordt aangeraden gedurende 4 weken na de ingreep, dit betekent dat korte rustige wandelingen wel kunnen, maar grote fysieke inspanningen vermeden dienen te worden (bvb fietsen, zware lasten heffen, intensief sporten). Seksuele activiteit dient ook vermeden te worden de eerste 4 weken na de ingreep.

Bloedverdunners zullen na de ingreep gradueel herstart worden. Een concreet schema met de nodige voorschriften wordt voorzien bij ontslag, dit gaat frequent gepaard met Clexane® spuitjes ter overbrugging. De toediening van de spuitjes kan door een thuisverpleegkundige, waarvoor bij ontslag een thuiszorgattest wordt voorzien.

We raden gedurende 2 weken af om een warm bad te nemen of van een sauna gebruik te maken. Dit om het risico op nabloeding te vermijden. Douchen vormt geen probleem.

Alcoholgebruik dient tot 2 weken na de ingreep beperkt te worden, gezien het verhoogde risico op nabloeden na alcoholinname.

TED-kousen dienen thuis best nog 2 weken 's nachts gedragen te worden gezien u dan minst in beweging bent.

In sommige situaties (bvb bij onmogelijkheid tot spontaan plassen na verwijderen van de sonde (= urinaire retentie)) dient de blaassonde in de blaas te blijven bij ontslag. Deze sonde wordt in dat geval doorgaans voor 7-10 dagen behouden en verwijderd via een dagopname op onze dienst.

Na de ingreep en verwijderen van de sonde kan het zijn dat

- Er nog enkele dagen bloed in de urine te zien is
- Het plassen dringender verloopt met soms ongewild urineverlies
- Er een gevoel van blaasprikkeling of blaaskrampen is
- De plasvolumes eerder kleiner zijn
- Er een continue plasdrang is

Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en kunnen medicamenteus worden opgevangen door middel van anticholinergica (bvb solifenacine of oxybutynine) of β-3-adrenoceptor-agonist (bvb vibegron of mirabegron).

10. Alarmtekens

Alertheid voor eventuele complicaties is belangrijk. In volgende situaties raden wij aan uw Uroloog te contacteren of zich te melden via Spoedgevallen:

- Koorts boven de 38.5°C of koude rillingen
- Ernstige onderbuikspijn die met klassieke pijnstilling of de voorgeschreven medicatie niet onder controle geraakt
- Uitgesproken bloed in de urine met bloedklonters
- Onmogelijkheid te urineren of erg pijnlijke gevoel bij het plassen.

⇨ Indien u twijfelt over uw symptomen kan u altijd contact opnemen met de dienst Urologie.

11. Checklist: wat breng ik mee bij een opname?

- Thuismedicatie, bij voorkeur in de originele verpakking. Inclusief eventuele antibiotica of bloedverdunners.
- TED-kousen zo u dit heeft
- Nachtkledij
- Toiletgerief
- GSM en oplader
- Eventuele vragenlijsten of papieren die u nog waren gevraagd in te vullen
- Verzekeringspapieren die dienen getekend te worden door de arts

12. Vragen? Noteer ze hieronder.

13. Contact

Hospitalisatieafdeling Urologie
Tel. 09 332 27 61

Polikliniek Urologie
Tel. 09 332 22 76

https://youtu.be/JIu6tK6jZx8